

LE CANCER DE LA VULVE

I. Introduction

- Le cancer de la vulve est une prolifération néoplasique maligne qui se développe sur l'ensemble des formations génitales externes de la femme.

- C'est une pathologie rare:

- 3-5 % des cancers gynécologiques

- 4^{ème} cancer gynécologique

- Deux grandes entités différentes du cancer de la vulve :

- Le cancer vulvaire de la femme plutôt jeune (40 – 50 ans) = un contexte d'infection à HPV de type 16 puis 18 :

- Souvent il est associé à d'autres lésions : col, vagin, canal anal
- En général sont des lésions multifocales
- Evolue à partir des VIN communs = VIN classiques (VIN usual type)

- Le cancer de la femme âgée (70 – 80 ans) : secondaire à des lésions dégénératives (lichen scléro-atrophique, lichen plan) :

- Physiopathologie mal connue
- Evoluent à partir du VIN différencié
- Non HPV induits
- Lésions sont en général unifocales
- Evoluent à partir du lichen scléro-atrophique
- Le lichen évolue vers un cancer invasif que dans 5 – 10% des cas

- Cependant : Augmentation nette de l'incidence des néoplasies intra-épithéliales vulvaires (VIN)

- Cancer invasif : est une pathologie de la femme ménopausée (>70 ans)

- VIN : Est une pathologie de la femme jeune

- Le diagnostic :

- Est facile : la vulve est un organe accessible à l'examen.
- Doit-être précoce,
- Passe par la recherche des facteurs de risque.

- Le traitement :

- La chirurgie est la meilleure option curative
- De moins en moins mutilante

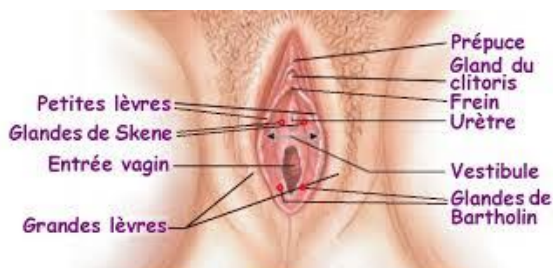
- Le pronostic : Bon, Dépend du stade

- Stade précoce :

- La réduction de l'importance de l'exérèse chirurgicale avec des résections plus limitées
- Et le développement de la technique du ganglion sentinelle

➔ Réduction considérable de la morbidité et des séquelles de la chirurgie sans altérer les chances de guérison

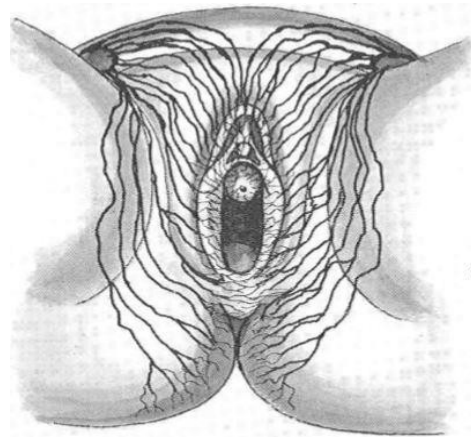
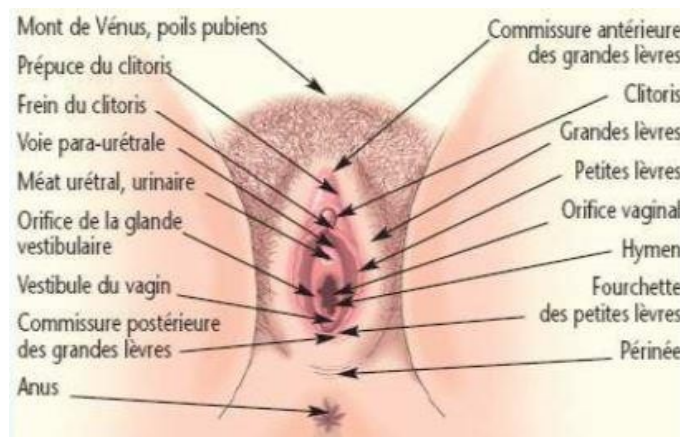
II. Rappel anatomique



Vulve=plusieurs organes

- formations labiales
 - Grandes lèvres
 - Petites lèvres
- organes érectiles
 - Clitoris
 - Bulbes vestibulaires
- glandes vulvaires
 - Majeures ou glande de Bartholin
 - Mineures ou glandes de Skene
- vestibule ou espace inter labial

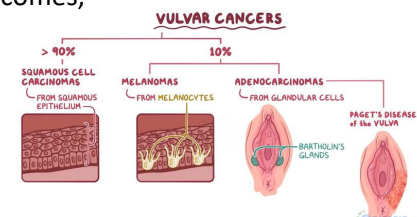




La vulve st une « éponge lymphatique »

III. Anatomie pathologique : Les types histologiques sont variés

- **Tumeurs épithéliales** (> 90 %) des cas: carcinome épidermoïde, carcinomes verruqueux; carcinomes baso-cellulaires
- **Tumeurs glandulaires**: Adénocarcinomes (Glandes de Bartholin; Glandes de Skene.;etc.).
- **Tumeurs de mésenchyme**: = Sarcomes (Leiomyosarcomes, Rhabdomyosrcomes; liposarcomes, Angiosarcomes).
- **Tumeurs mélanocytaires**: Mélanomes malins
- **Autres (Rares)**: Lymphomes, Schwanomes



IV. Facteurs de risque :

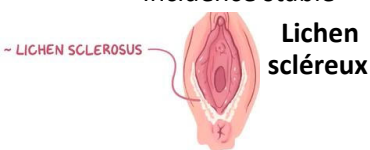
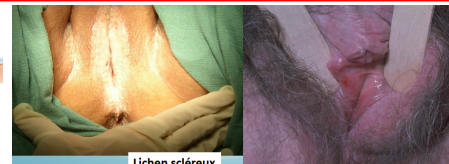
- Evolution : Longtemps après une **néoplasie intra-épithéliale vulvaire (VIN)** ;

- Deux mécanismes :

1. Cancers non HPV induites:

- Terrain d'hypo-œstrogénie: Le Kc survient longtemps après une lésion précancéreuse: Lichen scléreux d'évolution chronique.

- Le lichen dégénère dans **10 à 15 % des cas**
- Femmes ménopausées âge avancé (> 65 ans)
- Incidence stable



Lichen scléreux

Lichen scléreux + hyperplasie épithéliale (VIN I-II)

Cancer de la vulve invasif

2. Cancers non HPV induites:

- De plus en plus fréquente
- Femmes de plus en plus jeunes (40–50 ans)
- L'évolution passe par la **maladie de Bowen** ou la **papillomatose bowénoïde**.
- **TOUJOURS**: Rechercher des lésions cervicale, vaginales ou anales associées
- Histoire naturelle:

Infection à HPV oncogène



Maladie de Bowen , papulose Bowénoïde (PB)



Néoplasies vulvaires intra-épithéliales - CIS



Cancer invasif ?

a. La maladie de Bowen:





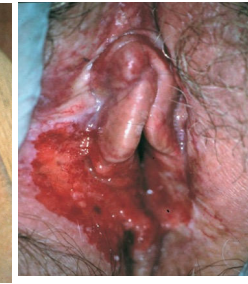
- Carcinome in situ
- Carcinome épidermoïde intra-épithélial
- Carcinome intra-épidermique
- VIN3
- La maladie de Bowen touche la femme ménopausée

Facteurs de risque :

- ❖ HPV: HPV 16 et 18
- ❖ Tabagisme: association dans 70 %
- ❖ Terrain immuno-deprimé

Cliniquement:

- Touche la femme de plus de 60 ans
- Une plaque rouge, irrégulière, recouverte de fines squames
- Si pas de traitement spécifique, elle évolue LENTEMENT vers un cancer invasif
- Le diagnostic passe par une biopsie
- Toujours : rechercher d'autres localisations surtout au niveau du col, vagin, canal anal



b. La papulose bowénoïde :

Cliniquement :

- Touche la femme Jeune
- Variété de papulose érythémateuse ou pigmentée
- Les lésions sont multiples et polymorphes
- Elles sont multifocales et s'étendent à la région périnéale et péri-anale.
- Sont souvent associées à :
 - Une CIN 3 du col (Cervix intra-epithelial neoplasia)
 - Une VaIN 3 (vaginal intra-epithelial neoplasia)
 - VIN (Vulvar intra-epithelial neoplasia)
 - AIN 3 (Anal intra-epithelial neoplasia)



IV – Facteurs de risque:

= Les lésions intra-épithéliales de la vulve (VIN):



	Carcinome épidermoïde	Carcinome basaloïde
Prévalence et âge	80 %, femmes âgées	20 %, femmes jeunes
Morphologie	Kératinisant	Verruqueux
Association avec VIN	VIN différencié	VIN associé à l'HPV (v-HSIL)
Association avec lichen scléreux	Fréquent	Rare
HPV	Non	Oui
Immunohistochimie	P53 : parfois positif P16 : négatif (ou faible)	P53 : négatif P16 : positif

	VIN communs	VIN différenciés
Base	HPV induit	Lichen scléreux
Origine des cancers	30%	70%
Age	Jeune	Avancé
Site	Uni-, multifocal	Unifocal ± étendu
Aspect	Varié	Erosif, hyperkératosique
Plaintes	Multiples • prurit 30% • douleurs 25% • gêne 80%	Récurrentes • prurit 50% • saignement 20% • brûlures 80%

ISSVD 1986	ISSVD 2005	En relation avec
VIN 1	Condylome plan	HPV bas risque
VIN 2	VIN commun	HPV haut risque
VIN 3	VIN commun	HPV haut risque
VIN 3 différencié	VIN différencié	Lichen scléreux
	VIN inclassable	Type maladie pagétoïde



La société internationale des études des pathologies vulvaires (ISSVD):



Nouvelle nomenclature des VIN 2015

Ancienne terminologie	Terminologie de 2015
VIN 1	Lésion squameuse intra-épithéliale de bas grade, condylome plan, ou aspect HPV
VIN 2/3 classique	Lésion squameuse intra-épithéliale de haut grade
VIN 3 différenciée	Néoplasie vulvaire intra-épithéliale, de type différencié

Ancien terme	Nouveau terme	HPV ?	Risque
VIN 1	LSIL	Oui (bas grade)	Très faible
VIN 2/3 classique	HSIL	Oui (haut grade)	Élevé
VIN 3 différenciée	dVIN	Non	Très élevé

VIN "classique"	VIN "différenciée"
Aspect variable en fonction de l'âge et du statut immunitaire • Unifocal : maladie de Bowen, femme ménopausée • Multifocal : papulose Bowénoïde, femme jeune • Formes confluentes, femme immunodéprimée	• Correspondent à 30 % des VIN • 5% évoluent vers le cancer • A l'origine de 70% des cancers épidermoïdes de la vulve
Associations à d'autres localisations • Anale, vaginale, orale, cervicale • De survenue décalée dans le temps	Lésion squameuse intra-épithéliale de haut grade, aspect classique

V. Mode d'extension

1. Extension locale

- Tumeur de la vulve est souvent exophytique
- Site variable : Surtout la grande lèvre
- Les lésions bilatérales sont rares (stades avancés)
- L'extension se fait en profondeur et en surface :
 - Vagin,
 - Urètre,
 - Fosse ischio-rectale,
 - Fourchette vulvaire
 - Canal anal

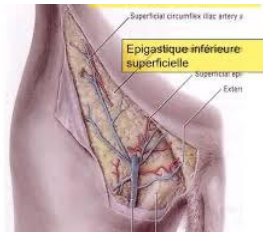
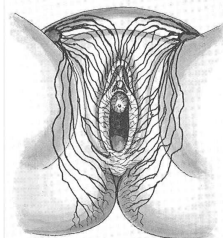
2. Extension régionale:

- Elle est lymphatique ;
- Le cancer de la vulve est très lymphophile :
 - Extension vers les GG inguinaux superficiels puis profonds (séparés par le fascia cribriforme)
 - Puis vers les ganglions iliaques externes
 - Puis vers les ganglions lombo-aortiques
- Extension lymphatique bilatérale dans 30 % des cas (Même si tumeur unilatérale: Riche réseau anastomotique lymphatique)
- L'extension lymphatique est corrélée à l'infiltration en profondeur du stroma

1986 ISSVD 2003 OMS	2004 ISSVD	2012 LAST	2015 ISSVD 2014 OMS	2020 OMS
VIN Type squameux 1) VIN I 2) VIN II 3) VIN III 1) VIN différenciée	VIN Flat condylome ou effet HPV VIN de type usuel : 1) Warty type 2) Type basaloid 3) Type mixte VIN de type différencié	Lésions intraépithéliales : • Bas grade SIL-L SIL (VIN1) • Haut grade SIL-HSIL (VIN2, VIN3) Differentiated VIN (dVIN)	Vulvar squamous intraepithelial lesion (SIL) • LSIL de la vulve : LSIL vulvaire, flat condyloma or HPV effect • HSIL* : VIN de type usuel • dVIN	Vulvar squamous intraepithelial lesion (SIL) : • Lésions HPV induites : ◦ LSIL ◦ H-SIL* • Lésions HPV indépendantes



CAP/ASCCP Lower Anogenital Squamous Terminology for HPV-Associated Lesions



Profondeur d'infiltration (mm)	n	pN1 (%)
1,1-2	121	8 (6.6)
2,1-3	97	8 (8.3)
3,1-4	50	11 (22.0)
4,1-5	40	10 (25.0)
5	32	12 (37.5)

Profondeur infiltration (mm)	n	pN1(%)
1	120	0
1,1-2	121	8(6.6)
2,1-3	97	8(8.3)
3,1-4	50	11(22.0)
4,1-5	40	10(25.0)
5	32	12(37.5)

3. Extension générale métastatique:

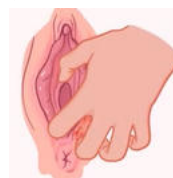
- Les métastases sont exceptionnelles
- Elles sont tardives
- Tumeurs très évoluées
- Sites: Foie, Poumon et os

V. Diagnostic positif :

1. Diagnostic clinique :

a. Signes fonctionnels :

- Facile mais il y a un retard diagnostique (pudeur des femmes)
- Maître symptôme = **PRURIT VULVAIRE** (45 à 75% des cas)
- 20 % des cas = tumeur vulvaire exophytique
- Parfois douleurs vulvaires
- Exceptionnellement : Saignement, Tr urinaires...etc

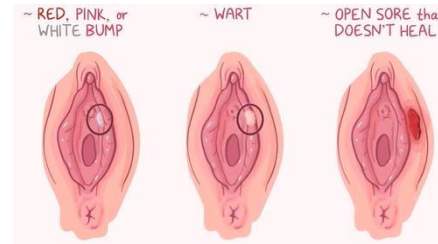


b. Inspection :

- Tumeur bourgeonnante, ulcéro-bourgeonnante
- Souvent surinfectée
- Très douloureuse,
- Toujours préciser: le siège (en général c'est la grande lèvre), la bilatéralité, la taille...etc

c. Palpation :

- Apprécier:
 - Le caractère infiltrant,
 - La mobilité,
 - L'extension aux organes de voisinage
 - L'existence ou des adénopathies inguinales.



2. Diagnostic paraclinique:

- La cytologie: à oublier
- La biopsie: au moindre doute sous anesthésie locale.



VI. Classification : Classification TNM du cancer de la vulve (7^{ème} édition 2009)

Tumeur primitive (T) :

T1	Tumeur limitée à la vulve ou au périnée
T1a	< 2 cm avec invasion stromale ≤ 1 mm
T1b	> 2 cm avec invasion stromale > 1 mm
T2	Tm (quelque soit la taille) avec envahissement du bas urètre et/ou du vagin ou de l'anus
T3	Envahissement tumoral du haut urètre, de la vessie, de la muqueuse rectale ou du pelvis

Ganglion régional (N) :

Nx	statut ganglionnaire non évaluable
N0	pas de métastase ganglionnaire
N1a	métastase(s) d'un ou deux ganglions < 5 mm
N1b	métastase d'un ganglion > 5 mm
N2a	métastases de 3 ganglions ou plus < 5 mm
N2b	métastases de 2 ganglions ou plus > 5 mm
N2c	métastases ganglionnaires avec effraction capsulaire
N3	métastases ganglionnaires fixées, ulcérées

Métastases à distance (M) :

Mx	statut métastatique à distance non évaluable
M0	pas de métastases à distance
M1	métastases à distance

Classification FIGO (Fédération Internationale de Gynécologie-Obstétrique 2021)



Nouvelles classification FIGO 2021

Stade	Description	survie à 5 ans
I	Confiné à la vulve	
IA	≤ 2 cm dans toutes ses dimensions et ≤ 1 mm d'invasion stromale	> 90%
IB	> 2 cm dans une quelconque des dimensions ou > 1 mm d'invasion stromale	
II	Tumeur de taille quelconque avec extension par contiguïté (tiers inférieur de l'urètre, tiers inférieur du vagin ou de l'anus) et pas de métastase ganglionnaire lymphatique	80%
III	Tumeur de toute taille, avec extension à la partie supérieure des structures adjacentes ou avec un nombre quelconque de ganglions lymphatiques non fixés, non ulcérés	
IIIA	Extension aux deux tiers supérieurs de l'urètre ou aux deux tiers supérieurs du vagin ou à la muqueuse de la vessie ou à la muqueuse rectale ou avec des métastases ganglionnaires régionales ≤ 5 mm	50-60%
IIIB	Métastases ganglionnaires régionales (inguinales et fémorales) > 5 mm	
IIIC	Métastases ganglionnaires régionales (inguinales et fémorales) avec extension extracapsulaire	
IV	Tumeur de toute taille fixée à l'os ou fixe, métastases ganglionnaires ulcérées ou à distance	
IVA	Tumeur fixée à l'os pelvien ou métastases ganglionnaires régionales fixes ou ulcérées	15%
IVB	Métastases à distance	

STAGING: TNM SYSTEM

	STAGE I	STAGE II	STAGE III	STAGE IV
T TUMOR SIZE & LOCAL EXTENSION				
N LYMPH NODE METASTASES	×	×	✓	N/A
M DISTANT METASTASES	×	×	×	✓

* Ce système de classification par stades est le système de classification 2021 de l'International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) pour la plupart des cancers vulvaires, à l'exception du mélanome vulvaire. Le mélanome vulvaire doit être classé par le système de classification par cancer de la vulve de l'AJCC 2017, basé sur la FIGO et l'American Joint Committee on Cancer (AJCC), AJCC Cancer Staging Manual, ed. 8. New York, Springer, 2017.

VII. Facteurs pronostiques :

1. Envahissement ganglionnaire:

- **Stade I:** 10 % des ganglions sont envahis
- **Stade II:** 25 % des ganglions sont envahis
- **Stade III:** 65 % des ganglions sont envahis
- **Stade IV :** 90 % des h-ganglions sont envahis
 - Localisations latérales: Envahissement des ganglions ipsilatéraux
 - Localisations clitoris: Envahissement des ganglions profonds

2. Envahissement en profondeur: Seul un envahissement du stroma de moins de 1 mm est de bon pronostic.

VIII. Traitement :

1. Moyens thérapeutiques:

a. La chirurgie : Le traitement principal est la chirurgie

❖ Traitement conservateur :

- Exérèse tumorale large en largeur et en profondeur
- Hemi-vulvectomie antérieure ou postérieure +/- transposition de lambeaux myo-cutanés.
- Lymphadénectomie inguinale bilatérale

❖ Traitement radical:

- Intervention de Basset
- Vulvectomie bilatérale
- Lymphadénectomie inguinale bilatérale associée à une lymphadénectomie inguinale bilatérale

❖ Curage inguinal: superficiel et ou profond

- Par chirurgie classique
- Par vidéo-endoscopie

b. La radiothérapie :

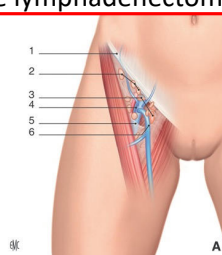
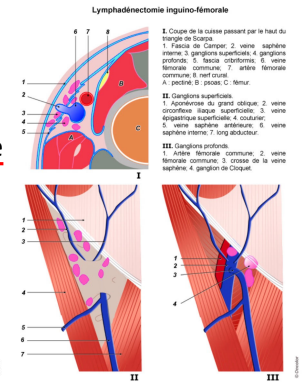
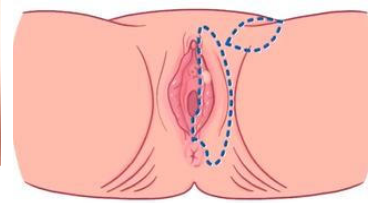
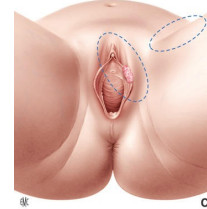
- Lit tumoral + ganglions inguinaux
- Intérêt:
 - En pré-opératoire: Réduction du volume tumoral
 - En post-opératoire: réduction du risque de récurrence

c. La chimiothérapie :

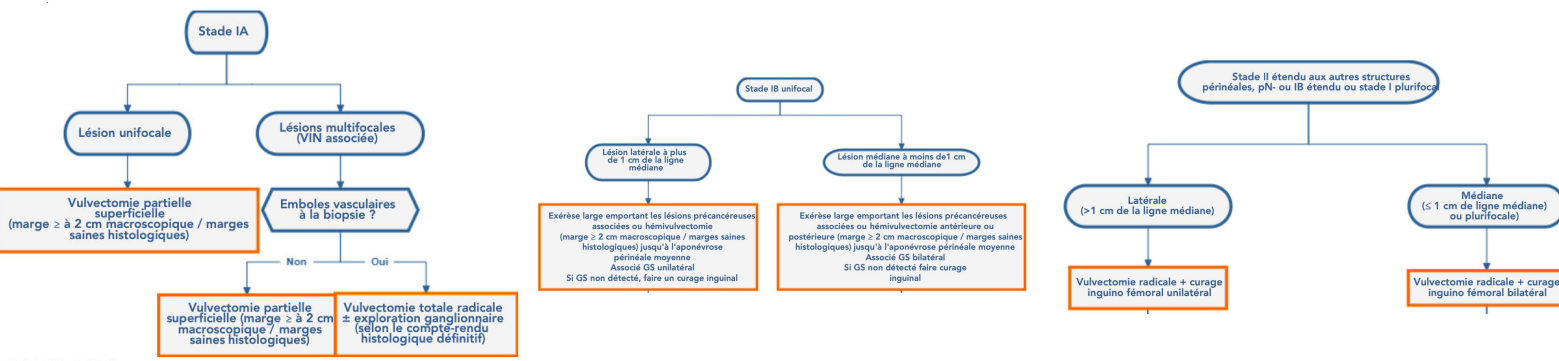
- Si mélanome malin
- Si métastases

2. Indications: La prise en charge doit-être multi-disciplinaire

- Stade I a + infiltration de moins de 1 mm: Traitement conservateur + Radiothérapie si ganglions envahis
- Autres stade I a OU infiltration de plus de 1 mm : Traitement radical + Radiothérapie externe
- Mélanome malin: Traitement radical + curage inguinal + Chimiothérapie



Facteurs de risque de récurrence:



Prise en charge des lésions intra-épithéliales de la vulve (VIN):

Surveillance:

